

ORTODONTİK TEDAVİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Hasta Adı Soyadı:	T.C. Kimlik No:	Tarih: / / 20.... Saat: :
----------------------------	--------------------------	--

1. Teşhis / İşlem Planlanan Diş veya Bölge

Hekim; ortodontik tedavi planlanan diş/bölgeleri şema üzerinde işaretler; teşhis ve planı aşağıya yazar.

Üst Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Alt Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
Ortodontik teşhis / kapanış problemi / şikâyet:																
Planlanan tedavi:	Sabit ortodontik tedavi / hareketli aparey / fonksiyonel aparey / şeffaf plak / retainer-pekiştirme / mini vida / diğer:															
Çekim planı / aparey tipi / özel not:																

2. Lokal Anestezi Bilgilendirmesi ve Komplikasyonları

Ortodontik tedavi sürecinde gerekli görülürse; bant yerleştirme, mini vida uygulaması, çekim, gingival düzeltme veya yardımcı küçük cerrahi işlemler için lokal anestezi uygulanabilir. Kliniğimizde lokal anestezi amacıyla lidokain ve/veya artikain etken maddeli, adrenalini veya adrenalinsiz anestezik solüsyonlar kullanılabilir. Lokal anestezi sonrasında geçici uyuşukluk, dudak/yanak/dil ısırmasına bağlı travma, enjeksiyon yerinde ağrı, hematoma, şişlik, çene kaslarında hassasiyet, ağız açmada zorlanma, nadiren bayılma, kalp çarpıntısı, tansiyon değişikliği, sinir etkilenmesi, alerjik reaksiyon ve nadiren anafilaksi gelişebilir.

3. SABİT ORTODONTİK TEDAVİ ☐

Kapsam: Bu bölüm sabit ortodontik tedavileri kapsar. Metal veya estetik braketler, tüpler, ark telleri, elastikler, zincirler, ataşmanlar, ağız dişi/yardımcı elemanlar ve gerekli görülürse mini vida gibi yardımcı uygulamalar kullanılabilir.

İşlemden beklenen faydalar: Diş çapraşıklığı, aralık, kapanış bozukluğu ve çene ilişkilerinin düzeltilmesi; estetik görünümün, çiğneme fonksiyonunun ve ağız hijyeninin iyileştirilmesi; dişlerin daha sağlıklı, dengeli ve fonksiyonel konuma getirilmesi beklenir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Klinik ve radyolojik değerlendirme sonrası braketler diş yüzeylerine yapıştırılır, teller yerleştirilir ve periyodik kontroller yapılır. Gerekirse elastik, yay, yardımcı aparey, mini vida veya çekim planı uygulanabilir. İlk uygulama seansı çoğunlukla 30-90 dakika; kontrol randevuları genellikle 15-45 dakika sürer. Toplam tedavi süresi olgunun zorluk derecesine, büyüme-gelişim durumuna, hasta uyumuna ve randevu düzenine göre değişmekle birlikte çoğu vakada aylar-yıllar sürebilir.

Alternatifler: Hareketli aparey, şeffaf plak tedavisi, koruyucu/pekiştirici tedaviler, çekimli veya çekimsiz alternatif planlar, yalnızca estetik düzleme, protetik/restoratif seçenekler ya da tedavisiz takip değerlendirilebilir. Her alternatif her hasta için uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin başarı, belirli süre veya tam estetik memnuniyet garantisi verilemez. Tedavi sırasında ağrı, hassasiyet, çiğneme zorluğu, ağız içi yara, dudak-yanak irritasyonu, braket/tel kopması, mini vida gevşemesi, ağız hijyeninin bozulmasına bağlı beyaz leke, çürük, diş eti iltihabı/büyümesi/çekilmesi, kök rezorpsiyonu, dişlerde geçici sallanma hissi, diş canlılığında etkilenme, çene eklemi veya kas şikâyetleri, istenmeyen diş hareketleri ve tedavi süresinin uzaması görülebilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Ortodontik sorunlar tedavi edilmezse çapraşıklık, kapanış bozukluğu, estetik kaygı, çiğneme ve konuşma sorunları, ağız hijyeninde güçlük, diş eti problemleri, aşınma, travmatik kapanış, bazı dişlerde yüklenme artışı ve uzun dönemde fonksiyonel problemler devam edebilir veya ilerleyebilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, alerjilerini, kullandığı ilaçları, ağız solunumu, tırnak yeme, parmak emme, diş sıkma ve çene eklemi şikâyetlerini hekime bildirmelidir. Sert/yapışkan gıdalardan kaçınılmalı, ağız hijyenini titizlikle sağlamalı, lastik/aparey kullanım talimatlarına uymalı ve kontrolleri aksatmamalıdır. Braket kopması, tel batması, şiddetli ağrı, diş eti şişliği veya belirgin uyumsuzluk halinde kliniğe başvurulmalıdır.

4. HAREKETLİ APAREY / ŞEFFAF PLAK / PEKİŞTİRME TEDAVİSİ ☐

Kapsam: Bu bölüm hareketli apareyleri, fonksiyonel ortodontik apareyleri, şeffaf plak (aligner) tedavisini ve tedavi sonrası retainer/pekiştirme dönemini kapsar.

İşlemden beklenen faydalar: Uygun vakalarda diş hareketlerinin yönlendirilmesi, ark gelişiminin desteklenmesi, alışkanlıkların kontrolü, estetik ve fonksiyonun iyileştirilmesi; tedavi sonrası dişlerin yeni konumlarının korunması beklenir.

Şeffaf plak / aparey / retainer özel bilgilendirmesi: Hareketli apareyler, şeffaf plaklar ve retainerlar ancak önerilen sürelerde düzenli kullanılırsa etkili olur. Plak/aparey yeterli süre takılmazsa tedavi ilerlemesi yavaşlayabilir, plan değişebilir veya hedeflenen sonuç elde edilemeyebilir. Retainerların kullanılmaması halinde tedavi sonrası dişlerde nüks (relaps) görülebilir ve dişler eski konumlarına dönebilir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Ölçü/dijital tarama, kayıtlar ve planlama sonrası hareketli aparey, şeffaf plak veya retainer hazırlanır ve kullanım şekli anlatılır. Kontrollerde ilerleme değerlendirilir, gerekirse aparey ayarlanır veya yeni plaklar verilir. Teslim seansları ve kontroller genellikle 15-45 dakika sürer. Toplam tedavi süresi olguya, aparey tipine ve hasta uyumuna göre değişir.

Alternatifler: Sabit ortodontik tedavi, farklı aparey türleri, retansiyon planının değiştirilmesi, çekimli/çekimsiz alternatifler veya tedavisiz takip seçenekleri değerlendirilebilir. Her yöntem her hastaya uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Aparey/plak uyumsuzluğu, baskı ve ağrı, konuşma alışkanlığında geçici değişiklik, tükürük artışı, bulantı hissi, apareyin vurması, kırılması, kaybı, renklenmesi, kullanım düzensizliğine bağlı etkinliğin azalması, ağız hijyeni bozukluğu, çürük/diş eti sorunları ve nüks/relaps görülebilir. Şeffaf plaklarda ataşman düşmesi veya plak çatlaması/kayıp da olabilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Hareketli ortodontik tedavi veya pekiştirme uygulanmazsa mevcut ortodontik problem devam edebilir; erken düzeltme fırsatı kaçabilir; tedavi sonrası retansiyon yapılmazsa dişler yeniden yer değiştirebilir ve ortodontik kazanımların bir kısmı kaybedilebilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta aparey/plak kullanım süresine uymalı, hijyen kurallarına dikkat etmeli, apareyi/plakları korumalı ve düzenli kontrolleri aksatmamalıdır. Ağız içi yara, uyumsuzluk, kırık, kayıp, aşırı ağrı veya tedavinin ilerlemediği düşünülüyorsa kliniğe başvurulmalıdır. Çocuk hastalarda ebeveyn desteği ve kullanım takibi tedavinin başarısı açısından önemlidir.

5. Kullanılabilecek İlaçlar, Materyaller ve İstenmeyen Etkiler

Ortodontik tedavi sürecinde gerekli görülürse lokal anestezi, ağrı kesici, antiinflamatuvar, antiseptik gargara veya hekimin uygun gördüğü diğer ilaçlar kullanılabilir/reçete edilebilir. Braket, bant, yapıştırıcı, tel, elastik, mini vida, plak/aparey materyalleri veya ilaçlara bağlı mide rahatsızlığı, baş dönmesi, uyku hali, cilt döküntüsü, ağız içi irritasyon, alerjik reaksiyon ve nadiren anafilaksi gelişebilir.

6. Onam Beyanı

Yukarıdaki bilgileri okudum. Sabit ortodontik tedavi, hareketli aparey, şeffaf plak ve/veya pekiştirme tedavisinin nasıl yapılacağı, tahmini süreleri, işlemten beklenen faydaları, alternatifleri, yapılmazsa oluşabilecek sonuçları, lokal anestezi ve ilaç/materyal riskleri, işlem öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar, riskler ve komplikasyonlar hakkında hekimim tarafından anlayabileceğim şekilde bilgilendirildim. Bu formdaki bilgiler tarafıma hekimim tarafından sözlü olarak da açıklanmıştır. Sorularımı sorma fırsatı buldum ve yeterli yanıt aldım. Uygun görülen ortodontik işlemlerin yapılmasını kabul ediyorum.

7. İmza Alanı

Hasta el yazısı ile:

(noktalı alana “okudum anladım onaylıyorum” yazınız)

Hasta / Yasal Temsilci - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Hekim - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Yasal temsilci imzasında yakınlık derecesi ve temsil nedeni hasta dosyasına ayrıca kaydedilir.